

Какие способы лучевого исследования могут быть использованы при обследовании больных с заболеваниями лёгких: {

~рентгендиагностическое исследование:

~ангиография:

~КТ:

~УЗИ:

=правильно всё перечисленное

}

Какие способы рентгенологического исследования могут быть использованы при обследовании больных с заболеваниями лёгких: {

~рентгеноскопия, рентгенография:

~флюорография:

~томография:

~бронхография:

=правильно всё перечисленное

}

Случаи использования томографии лёгких: {

~%33,3333%определение глубины залегания опухоли и других патологических образований:

~%33,3333%выявление неоднородности опухолевых образований:

~%33,3333%выявление состояния крупных бронхов и лимфатических узлов:

~%-100%уточнение структуры лёгочной ткани:

}

Перечислите случаи, когда целесообразно использовать радионуклидное исследование лёгких: {

~сцинтиграфическое выявления при тромбоэмболиях;

~сцинтиграфическая дифференцировка тромбоэмболии лёгочной артерии и инфаркта миокарда при клинически неясных случаях:

~радиопульмонографическая оценка состояния внешнего дыхания:

~сцинтиграфическое выявление объёма выключенного кровотока при опухоли лёгкого:

=правильно всё перечисленное

}

В каких случаях целесообразно использовать ангиографическое исследование лёгких: {

~дифференциальная диагностика кисты и злокачественной опухоли:

~выявление усиления лёгочного рисунка:

~выявление острой пневмонии:

=выявление сдавления верхней полой вены опухолью:

~выявление сдавления корня лёгкого:

}

Вздутие участка лёгкого характеризуется: {

=просветлением:

~затемнением

~обширным затемнением

~очаговым затемнением

}

Полость в лёгком характеризуется: {

=просветлением:

~затемнением

~обширным затемнением

~очаговым затемнением

}

Выпот в плевральной полости характеризуется: {

~ очаговым просветлением:

=затемнением:

~обширным просветлением:

~кольцевидной тенью с горизонтальным уровнем жидкости

}

Опухоль, исходящая из стенки грудной полости, характеризуется: {

~просветлением:

=затемнением:

~очаговым затемнением:

~кольцевидной тенью:

}

Перечислите причины, проявляющиеся на рентгенограммах затемнением лёгких: {

~инфильтрация лёгочной ткани:

~опухолевая ткань в лёгком:

~ателектаз в лёгком:

~развитие соединительной ткани в лёгком:

=правильно всё перечисленное

}

По каким рентген признакам можно оценить смещение органов средостения влево: {

~%33,33333%смещение сосудистого пучка влево:

~%33,33333%смещение изображения трахеи влево:

~%33,33333%обнажение правого края позвоночника:

~%-100%смещение левого контура сердца кнаружи за среднеключичную линию:

}

Симптом «ограниченное просветление» может встречаться при: {

=вздутии участка лёгкого:

~выпоте в плевральную полость

~опухоли, исходящей из стенки грудной полости

~опухоли, исходящей из стенки миокарда.

~опухоли, исходящей из стенки аорты

}

Симптом «затемнение» может встречаться при: {

~вздутии участка лёгкого:

~полости в лёгком:

~ опухоли, исходящей из стенки аорты

=выпоте в плевральную полость:

}

Перечислите причины, вызывающие на рентгенограмме затемнение лёгких: {

~инфильтрация лёгочной ткани:

~опухолевая ткань в лёгком:

~ателектаз в лёгком:

~развитие соединительной ткани в участке лёгкого:

=правильно всё перечисленное

}

Синдром круглой тени в лёгком характерен, для: {

~%50%периферического рака без распада:

~%-50%воздушной кисты лёгкого:

~%50%туберкулемы:

~%-50%абсцесса лёгкого:

}

Синдром кольцевидной тени в лёгком характерен для: {

~периферического рака:

=воздушной кисты:

~туберкулемы:

~абсцесса лёгкого:

~центрального рака

}

Синдром кольцевидной тени в лёгком с горизонтальным уровнем жидкости характерен для: {

~периферического рака:

~воздушной кисты:

~туберкулемы:

=абсцесса лёгкого:

~центрального рака

}

Синдром однородного изменения корня лёгкого характерен для: {

~периферического рака:

~воздушной кисты

~туберкулемы:

~абсцесса лёгкого

=центрального рака

}

Укажите рентгенологический синдром, встречающийся при острой пневмонии:

{

~очаги и ограниченная диссеминация:

~круглая тень:

~тотальное затемнение:

=ограниченное затемнение

}

При каких заболеваниях лёгкого средостение смещается в сторону тотального затемнения: {

~%50%ателектаз:

~%-50%экссудативный плеврит:

~%50%цирроз лёгкого:

~%-50%острая пневмония:

}

Какие заболевания лёгких проявляются очаговыми тенями в лёгочном поле: {

~%-50%острая пневмония:

~%50%туберкулёз:

~%50%метастазы злокачественной опухоли в лёгких:

~%-50%киста лёгкого:

}

Какие заболевания сопровождаются усилением лёгочного рисунка: {

=венозное и артериальное полнокровие лёгких:

~эмфизема лёгких:

~острые воспалительные заболевания:

~хронические воспалительные заболевания

}

Какие заболевания лёгких могут сопровождаться увеличением лимфоузлов корня лёгкого: {

~%33,33333%туберкулёз:

~%33,33333%системное заболевание лимфоузлов:

~%33,33333%рак лёгкого:

~%-50%эмфизема;

~%-50%острый бронхит;

}

Для выявления бронхоэктазов наиболее информативной методикой является: {

~рентгенография:

~томография:

=бронхография:

~ангиопульмонография

}

Для выявления увеличенных лимфатических узлов средостения наиболее информативны: {

~%-33,33333%рентгенография:

~%-33,33333%ЗИ:

~%50%томография:

~%-33,33333%сцинтиграфия;

~%50%КТ;

}

В дифференциальной диагностике хронической пневмонии и туберкулеза легких имеет значение {

~%50%локализация:

~%-100%объем поражения:

~%50%наличие очаговых теней:

~%-100% наличие участка просветления

}

При бронхоэктатической болезни наиболее часто изменения локализуются:

{

~в верхней доле правого легкого:

=в средней доле:

~в нижней доле левого легкого

~в нижней доле правого легкого

}

Для туберкулезного бронхоаденита характерно: {

~двухстороннее поражение л/узлов с обезызвлениением:

=одностороннее увеличение одной или двух групп внутригрудных л/узлов

~расширение корня с сочетанием фокуса в легком:

~расширение корня с сочетанием фокуса в средостении:

}

Туберкулез внутригрудных л/узлов чаще встречается: {

=в детском и юношеском возрасте:

~в пожилом возрасте;

~в молодом возрасте

~в старческом возрасте

}

Для центрального рака с преимущественным эндобронхиальным ростом характерна: {

=нарушение бронхиальной проходимости

~узловое образование в области корня легкого:

~локальное усиление легочного рисунка

~ узловое образование в верхней доле легкого

}

К наиболее частым распространенным паразитарным заболеваниям легких относятся: {

~токсоплазмоз:

~гистоплазмоз:

~саркоидоз:

=эхинококкоз

}

Наиболее частая форма эхинококка легких: {

=овоидное гомогенное образование больших размеров:

~округлое образование:

~долевое уплотнение:

~образование неправильной формы

}

К лабораторным исследованиям подтверждающим диагноз эхиноккокоза относятся: {

~лабораторные тесты отсутствуют:

~клинический анализ крови:

~биохимические реакции:

=реакция Кацонни

}

Корень левого легкого расположен: {

=выше правого корня:

~на уровне правого корня:

~ниже правого корня

~ на уровне междолевой плевры

}

Что является морфологической единицей легкого: {

=ацинус:

~долька:

~сегмент:

~отдел

}

Назовите контрастное вещество применяемое при бронхографии: {

~технеций:

~билигност:

=пропилийодон

~омнипак

}

Средостение смещено в сторону затемнения при: {

~пневмонии:

=ателектазе:

~экссудативном плеврите

~туберкулезе

}

Ингаляционная сцинтиграфия предназначена для изучения: {

=вентиляционной функции легких:

~капиллярного снабжения легких:

~легочного кровотока

~сосудистого рисунка

}

Сцинтиграфические признаки рака легкого: {

=холодный очаг:

~горячий очаг:

~равномерное распределение РФП
 ~неравномерное распределение РФП
 }
 На чем основана позитивная сцинтиграфия с опухолевым РФП (цитратом галлия): {
 ~на изучении содержания РФП в бронхах:
 ~на изучении состояния легочного кровотока
 ~капиллярного снабжения легких:
 =на избирательном повышенном накоплении РФП в тканях злокачественной опухоли по сравнению с непораженной тканью легкого
 }
 Назовите проекцию косой междолевой щели: {
 =от остистого отростка Th-3 к месту соединения хрящевой части 4-ребра
 ~от остистого отростка Th-5 к месту соединения хрящевой части 5-ребра,
 ~на уровне 6-ребра
 ~на уровне 9-ребра
 }
 Ангиопульмонография это: {
 ~контрастирование бронхиальных артерий:
 ~контрастирование бронхов:
 ~контрастирование непарной вены
 =исследование системы легочной артерии:
 }
 Что означает термин «каваграфия» {
 =искусственное контрастирование верхней полой вены:
 ~контрастирование бронхиальных артерий,
 ~контрастирование бронхов
 ~контрастирование непарной вены
 }
 Что является субстратом «круглой тени» в легочном поле: {
 ~эозинофильный инфильтрат
 ~туберкулезный инфильтрат
 ~инфаркт легкого
 ~доброкачественная опухоль
 =все ответы правильны
 }
 Какие отделы легких чаще поражаются при туберкулезе: {
 =верхушки
 ~среднее легочное поле
 ~нижнее легочное поле
 ~все ответы правильны
 }

При малокровии легочной рисунок: {

~усилен ,

~сгущен ,

=обеднен

~все ответы правильны

}

Каковы причины спонтанного пневмоторакса {

~%50%разрыв стенки каверны

~%50%разрыв стенки кисты

~%-100%наличие экссудата

~%-100%все ответы правильны

}

При подозрении на бронхоплевральный свищ прибегают к: {

~томографии

=бронхографии

~сцинтиграфии

~все ответы правильны

}

Назовите рентгенологические симптомы тромбоэмболии легочной артерии : {

~расширение ствола легочной артерии

~ослабление сосудистого рисунка в зоне поражения,

~подъем купола диафрагмы на той же стороне,

=все ответы правильны

}

При тромбоэмболии крупных ветвей легочной артерий на сцинтиграмме будет выявляться: {

=холодный очаг

~горячий очаг

~неравномерное распределение РФП

~все ответы правильны

}

На рентгенограммах при абструктивном бронхите отмечают: {

~увеличение объема соединительной ткани в легких,

~эмфизема и легочная гипертензия

~относительно малые размеры сердца

=все ответы правильны

}

Назовите рентгенологическую картину пневмокониозов у шахтеров: {

~наличие выпота в плевральную полость

~обширное затемнение легкого

=наличие множественных очагов на фоне диффузного сетчатого фиброза

~все ответы правильны

}

Назовите основной рентгенологический признак кавернозного туберкулеза легких: {

- ~%50%наличие кальцевидной тени,
- ~%-100%наличие ограниченного затемнения,
- ~%50%наличие ограниченного просветления;
- ~%-100%все ответы правильны

}

Рентгенологическая картина малого периферического рака легкого: {

- =одиночный очаг в легком слабой интенсивности звездчатой формы,
- ~округлая тень с четкими обезыствленными контурами
- ~ограниченное затемнение легочного поля
- ~все ответы правильны

}

К числу сетчато-узелковых поражений относятся: {

- ~пневмокониозы
- ~саркоидоз
- ~токсические альвеолиты
- =все ответы правильны

}

Какой минимальный объема экссудата в легких выявляется при УЗИ: {

- ~3-мл
- ~5-мл
- =15-20 мл
- ~6-мл

}

Чем проявляется поражение плевры при рентгеноскопии: {

- ~%33,33333%неравномерным смещением куполов диафрагм
- ~%33,33333%ограничением подвижности куполов
- ~%33,33333%отсутствием подвижности
- ~%-50%наличием просветления
- ~%-50%наличием затемнения

}

Как смещаются куполы диафрагмы при акте дыхания в норме: {

- =равномерно
- ~неравномерно
- ~амплитуда колебаний неодинакова
- ~правый отстает в акте дыхания

}

Что может лежать в основе симптома «затемнение» {

- ~%33,33333%ателектаз
- ~%33,33333%инфильтрация легочной ткани
- ~%-50%пневмотораксе
- ~%-50%усиление легочного рисунка
- ~%33,33333%скопление жидкости

}

Частичное нарушение бронхиальной проходимости проявляется: {

~ателектазом

~пневмосклерозом

~пневмотораксом

=гиповентиляцией

~обтурационной эмфиземой

}

Что может лежать в основе симптома «просветление» {

~%-33,33333%опухолевое разрастание

~%-33,33333%пневмоническая инфильтрация

~%50%наличие полости

~%-33,33333%ателектаз

~%50%пневмоторакс

}

Какие заболевания чаще всего локализуются в переднем средостении {

~загрудинный зоб

~тимома

~тератома

=все ответы правильны

}

Какие заболевания обнаруживают чаще всего в заднем средостении {

~%50%нейрогенные опухоли и кисты

~%50%аневризмы нисходящей части аорты

~%-100%увеличенная вилочковая железа

~%-100%все ответы правильны

}

Перечислите органы, дающие при рентгеновском исследовании «тень» {

~%50%грудина

~%-50%желудок, заполненный газом

~%50%сердце

~%-50%лёгкие

}

Метод, позволяющий точно определить место положение опухоли в лёгком {

~бронхография

~рентгенография

~послойное исследование (томография)

=рентгенография в 2 -х взаимно- перпендикулярных проекциях

}

Какую цель преследуют, проводя исследование с введением газа в пространство около органа: {

~определение размеров органа:

~определение формы:

~определение функции:

=определение поверхности органа

}

Какие задачи решают, проводя рентгеновскую томографию лёгких в прямой проекции: {

~определение более точных чем на рентгенограмме размеров патологического очага:

~определение характера контуров очага:

~определение структуры патологического очага:

=правильно все

}

Рентгенологической картиной малого периферического рака легкого является: {

=одиночный очаг в легком слабой интенсивности, звездчатой формы

~округлая тень с четкими обывествленными контурами,

~ограниченное затемнение лёгочного поля

~все ответы правильны

}

Обострение хронической пневмонии рентгенологически подтверждаются выявлением: {

~усиления и деформация легочного рисунка

~плевральных наслоений

~бронхоэктазов

=инфильтративных изменений

}

Основном признаком хронического абсцесса является: {

~наличие полости

=сморщивающий процесс в лёгком

~плевральные шварты

~плевральные шварты

~плевральные шварты

}

Бронхиолит - это: {

~любое инородное тело бронха

~обывествленный лимфатический узел

=обывествленный лимфатический узел, пролабирующий в бронх

~все ответы правильны

}

Для диффузного пневмосклероза характерны: {

~усиление, деформация лёгочного рисунка

~грубый рисунок корней

~затемнение

=правильно все

}

К рентгенологическим симптомам острого бронхита относятся: {

- ~усиления лёгочного рисунка
- ~деформация лёгочного рисунка
- ~потеря структуры корней лёгких
- =отсутствие рентгенологических признаков

}

Дифференциальная диагностика туберкулемы и периферического рака основывается: {

- =на анализе характера контура
- ~на локализации опухоли
- ~на размерах образования
- ~на изменения плевры

}

Наиболее характерной локализацией центрального рака лёгкого является: {

- ~характерной локализации нет
- ~нижние отделы лёгкого
- =корень лёгкого
- ~верхние отделы лёгкого

}

На бронхограмме при центральном раке лёгкого определяется: {

- ~расширение бронхов
- ~отсутствие изменений в бронхах
- =культи, сужение бронхов
- ~деформация бронхов

}

При периферическом раке лёгкого контуры затемнения: {

- ~чёткие
- =фестончатые, нечеткие
- ~ровные
- ~определить невозможно

}

Для «верхушечного» рака характерно: {

- ~расположение тени в области вершины
- =расположение тени в области вершины в сочетании с деструкцией ребра:
- ~наличие «дорожки» к корню
- ~наличие полости распада

}

Поражение лимфоузлов средостения устанавливается на основании: {

- ~расширения тени средостения
- ~одностороннего расширения верхнего средостения
- ~полицикличности очертаний расширенного средостения
- =все ответы правильны

}

К наиболее частым паразитарным заболеваниям лёгких относятся: {

- ~токсоплазмоз

~парагонимоз

=эхинококкоз

~гистоплазмоз

}

К осложнениям возможным при эхинококкозе легкого относятся: {

~воспаление

~прорыв в бронх

~обсеменение легких

=все ответы правильны

}

Для туберкулезного бронхоаденита характерно: {

~двустороннее поражение внутригрудных лимфатических узлов

=одностороннее увеличение одной- двух групп внутригрудных лимфоузлов

~расширения корня лёгкого

~расширения корня лёгкого

}

При пневмотораксе лёгкое спадается: {

~кверху

~книзу

~вверх и медиально

=вниз и медиально

}

Анатомическим субстратом лёгочного рисунка в норме является: {

~бронхиальное дерево

~альвеолярная ткань

=ответвления лёгочных артерий и вен

~лимфатические сосуды

~лимфатические сосуды

}

Анатомическим субстратом корня лёгкого в норме являются: {

=стволы артерий и вен, бронхи

~стволы артерий и вен, лимфатические сосуды

~стволы артерий и вен, лимфатические узлы, клетчатка

~все ответы правильны

}

Для исследования капиллярного лёгочного кровотока используют: {

=перфузионную сцинтиграфию

~ингаляционную сцинтиграфию

~ангиопульмонографию

~доплерографию

}

Смещения средостения в здоровую сторону характерно для: {

~центрального рака лёгкого с ателектазом доли или сегмента

=экссудативного плеврита

~хронической пневмонии

~все ответы правильны

}

Смещение средостения в сторону поражения характерно для: {

~экссудативного плеврита

=цирроз лёгких

~диафрагмальной грыжи

~все ответы правильны

}

Абсцесс в лёгких характеризуется: {

~выпотом в плевральную полость

~инфильтратом в лёгком

~усилением лёгочного рисунка

=полостью содержащий газ и горизонтальный уровень жидкости

}

Признаки острой пневмонии характеризуются: {

~субтотальным затемнением

~участком просветления

=неоднородным затемнением с просветлением в нём бронхов

~ все ответы правильные

}

Деление рака на центральный и периферический обусловлено: {

~долевой локализацией

=уровнем поражения бронхиального дерева

~формой

~отношением к средостению

}

Для центрального рака с эндобронхиальным ростом характерно: {

=ателектаз

~узловое образование в области корня лёгкого

~локальное усиление лёгочного рисунка

~ все ответы правильные

}

Периферический рак исходит из эпителия: {

~долевых бронхов

~сегментарных бронхов

~субсегментарных бронхов

=альвеол

}

Для тромбоэмболии крупной ветви лёгочной артерии в ранние сроки характерно: {

~повышение прозрачности участка лёгочного поля

=локальное ослабление лёгочного рисунка

~диффузное усиление лёгочного рисунка

~понижение прозрачности участка лёгкого

}

При пневмотораксе в месте скопления воздуха наблюдают: {

~ослабление сосудистого рисунка

~усиление сосудистого рисунка

=усиление прозрачности лёгочного поля отсутствие сосудов

~ослабление прозрачности лёгочного поля

~ все ответы правильные

}

Ячеистая деформация лёгочного рисунка характерна для: {

~острой пневмонии

=интерстициальной пневмонии

~диссеминированного туберкулёза

~фиброзирующего альвеолита

~ все ответы правильные

}

Рентгенологическое повышение воздушности лёгочной ткани с обеднением лёгочного рисунка может наблюдаться: {

~при врождённой долеой эмфиземе

~при бронхиальной астме

~при инородных телах

=во всех случаях

}

Преимуществами УЗИ при пневмониях у детей: {

~возможность точной характеристики качества плеврального выпота

~возможность раннего выявления мелких очагов

~возможность точной характеристики точного объема

=правильно все

}

При отёке лёгких имеет место рентгенологический симптом: {

~«голова акулы»

~«мишени»

=«крыльев бабочки»

~«слоёного пирога»

}

Для диагностики бронхоэктазов используют при бронхографии контрастное вещество: {

~сульфат бария

=йдолипол

~гиппуран

~всё выше перечисленное

}

Застойные явления в лёгких рентгенологически проявляются: {

=сгущением деформации бронхососудистого рисунка:

~инфильтрацией верхних отделов
~пневмотораксом
~правильно выше перечисленное

}

Бронхиальные артерии питающие лёгочную ткань берут начало: {

=от грудной части аорты

~от лёгочных артерий

~от брюшной части аорты

~от сердца

}

О чёткости рентгенограмм грудной клетки судят по контурам: {

~средостения

~диафрагмы

~магистральных сосудов

=рёбер

}

В диагностике эмфиземы лёгких наиболее важными методиками являются: {

~рентгенография

=томография

~бронхография

~функциональные пробы

}

Для изучения структуры «круглой» тени наиболее информативна: {

~рентгеноскопия

~рентгенография

~рентгенография с прямым увеличенным изображением

=томография

}

Для пневмонии характерно: {

~просветление

= затемнение

~изменение корня

~изменение лёгочного рисунка

}

Правое лёгкое состоит из сегментов: {

~8

~9

=10

~11

}

На обзорной рентгенограмме грудной клетки в прямой проекции головка

корня левого лёгкого находится: {

=выше правого

~на одном уровне

~ниже правого

~ниже правого

}

Левое лёгкое состоит из сегментов: {

~6

~8

=9

~10

}

Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов чаще наблюдается: {

=в детском и юношеском возрасте

~в пожилом возрасте

~в молодом возрасте

~ в среднем возрасте

}

Обызыствление при периферическом раке лёгкого: {

~закономерны

~никогда не встречаются

=встречаются редко

~на фоне петрефеката

}

Томография и зонография дают возможность определить: {

~смещение органов средостения

~подвижность диафрагмы

~пульсацию сердца

=состояние лёгочной паренхимы и бронхов

}

Наиболее эффективной методикой исследования при «маленьком» (до 2 см) круглом образовании в лёгком является: {

~рентгеноскопия

~рентгенография

=томография

~бронхография

}

Основным признаком хронического абсцесса является: {

~наличие полости

=сморщивающий процесс в лёгком

~плевральные шварты

~бронхоэктазы

~ все ответы правильные

}

К рентгенологическим симптомам острого бронхита относятся: {

~усиления лёгочного рисунка

~деформация лёгочного рисунка

~потеря структуры корней лёгких

=отсутствие рентгенологических признаков

}

Дифференциальная диагностика туберкулемы и периферического рака основывается: {

=на анализе характера контура

~на локализации опухоли

~на размерах образования

~на изменения плевры

~ все ответы правильные

}

Центральный рак лёгкого чаще возникает в бронхах: {

~главных

~долевых

~промежуточных

=сегментарных

}

Наиболее характерной локализацией центрального рака лёгкого является: {

~характерной локализации нет

~нижние отделы лёгкого

=корень лёгкого

~ все ответы правильные

}

На бронхограмме при центральном раке лёгкого определяется: {

~расширение бронхов

~отсутствие изменений в бронхах

=культи, сужение бронхов

~деформация бронхов

}

При периферическом раке лёгкого контуры затемнения: {

~чёткие

=фестончатые, нечеткие

~ровные

~определить невозможно

}

Для «верхушечного» рака характерно: {

~расположение тени в области верхушки

=расположение тени в области верхушки в сочетании с деструкцией ребра

~наличие «дорожки» к корню

~наличие полости распада

}

Поражение лимфоузлов средостения устанавливается на основании: {

~расширения тени средостения

~одностороннего расширения верхнего средостения

~полицикличности очертаний расширенного средостения

=все ответы правильны

}

К наиболее частым паразитарным заболеваниям лёгких относятся: {

~токсоплазмоз

~парагонимоз

=эхинококкоз

~гистоплазмоз

}

К осложнениям возможным при эхинококкозе легкого относятся: {

~воспаление

~прорыв в бронх

~обсеменение легких

=все ответы правильны

}

Для туберкулезного бронхоаденита характерно: {

~двустороннее поражение внутригрудных лимфатических узлов

=одностороннее увеличение одной- двух групп внутригрудных лимфоузлов

~расширения корня лёгкого

~расширение средостения

}

При пневмотораксе лёгкое спадается: {

~кверху

~книзу

~вверх и медиально

=вниз и медиально

}

Для полной локализации опухоли в лёгких необходимы: {

=рентгенография в 2 -х перпендикулярных проекциях

~рентгеноскопия

~продольная томография

~рентгеноконтрастные препараты

}

Безвоздушный участок лёгочной ткани выглядит как: {

~просветление

=затемнение

~очаговое просветление

~обширное просветление

}

Компьютерная томография наиболее информативна при исследовании: {

=лимфатических узлов средостения

~пульсации сердца

~подвижности диафрагмы

~ все ответы правильные

}

Анатомическим субстратом лёгочного рисунка в норме является: {

~бронхиальное дерево

~альвеолярная ткань

=ответвления лёгочных артерий и вен

~лимфатические сосуды

}

Анатомическим субстратом корня лёгкого в норме являются: {

=стволы артерий и вен, бронхи

~стволы артерий и вен, лимфатические сосуды

~стволы артерий и вен, лимфатические узлы, клетчатка

~стволы артерий и вен

}

Для исследования капиллярного лёгочного кровотока используют: {

=перфузионную сцинтиграфию

~ингаляционную сцинтиграфию

~ангиопульмонографию

~доплерографию

}

Признаки острой пневмонии характеризуются: {

~субтотальным затемнением

~участком просветления

~тотальным затемнением

=неоднородным затемнением с просветлением в нём бронхов

}

Для центрального рака с эндобронхиальным ростом характерно: {

=ателектаз

~узловое образование в области корня лёгкого

~локальное усиление лёгочного рисунка

~узловое образование на периферии лёгкого

}

Для тромбоэмболии крупной ветви лёгочной артерии в ранние сроки характерно: {

~повышение прозрачности участка лёгочного поля

=локальное ослабление лёгочного рисунка

~диффузное усиление лёгочного рисунка

~диффузное просветление лёгочного рисунка

}

При пневмотораксе в месте скопления воздуха наблюдают: {

~ослабление сосудистого рисунка

~усиление сосудистого рисунка

=усиление прозрачности лёгочного поля отсутствие сосудов

~ослабление прозрачности лёгочного поля

~все ответы правильные

}

Рентгенологическое повешение воздушности лёгочной ткани с обеднением лёгочного рисунка может наблюдаться: {

~при врождённой долеой эмфиземе

~при бронхиальной астме

~при инородных телах

=во всех случаях

}

Для диагностики бронхоэктаза используют при бронхографии контрастное вещество: {

~сульфат бария

=йодолипол

~гиппуран

~РФП

}

Линия «Демуазо» наблюдается при: {

=экссудативном плеврите

~раке лёгкого

~саркоидозе

~пневмонии

~туберкулезе

}

Застойные явления в лёгких рентгенологически проявляются: {

=сгущением деформации бронхососудистого рисунка:

~инфильтрацией верхних отделов

~пневмотораксом

~правильно вышеперечисленное

}